

시험 관련 코멘트



실신은 뇌혈류량 감소로 인한 일시적 의식소실을 의미하는 것으로 보통은 증상이 경미하지만, 발작 및 응급 조치가 필요한 심장, 뇌질환일 경우를 감별해야 합니다. 따라서 병력 청취와 신체 진찰을 통해 원인 질환을 찾아내는 것이 중요하

며, 정말로 의식을 잃었는지, 쓰러질 것 같은 느낌이 있었는지 확인하는 작업이 선행되어야 합니다. 병력 청취에선 의식소실 전, 중, 후로 나누어서 생각하는 것이 좋습니다. 전조 증상은 있었는지, 실신 전에는 어떠한 증상이 있었는지, 실신 중에는 어떤 모습이었는지, 경련 발작이 있었는지(있었다면 경련 cpx), 그리고 실신 후에는 어떠한 증상이 있었는지 물어보는 것이 도움이 됩니다. 또한 말초신경, 심장, 뇌, 내분비 등의 원인으로 나누어 어떠한 상황에서 쓰러졌는지 자세하게 물으면 감별 범위를 좁혀갈 수 있습니다.

신체 진찰에서 실신 시 발생할 수 있는 외상을 꼭 확인해줘야 하며, 뇌 관련 문제가 있을 수 있으므로 간단히 할 수 있는 뇌신경검사인 light reflex와 안구운동검사를 등을 해야 합니다. 의심되는 발병 부위에 따라 신체 진찰의 구성 및 비중이 달라질 수 있는데, 신경과 질환이 의심되는 경우 신경과 진찰을 좀더 자세히 할 수 있고, 순환기 의심 시 심음 청진 및 경정맥 시진, 소화가 실혈이 의심될 경우 복부 진찰을 해 볼 수 있겠습니다. 상황에 맞는 유연한 환자 면담이 필요한 토픽이라고 생각됩니다.

실신의 원인에 따라 실신이 일어나는 상황을 피하도록 교육하고, 필요 시 두부 보호가 필요하다는 것을 주지시키는 것도 중요합니다. 많이 놀라진 않았는지, 몸 다친 곳은 없는지 걱정 및 공감 하면서 진료를 보면 한층 더 좋은 분위기 속에서 CPX를 마칠 수 있을 것입니다. 실신 관련 상황을 물어 볼 때에는 환자가 알아듣기 쉬운 용어로 질문하는 것이 좋습니다.

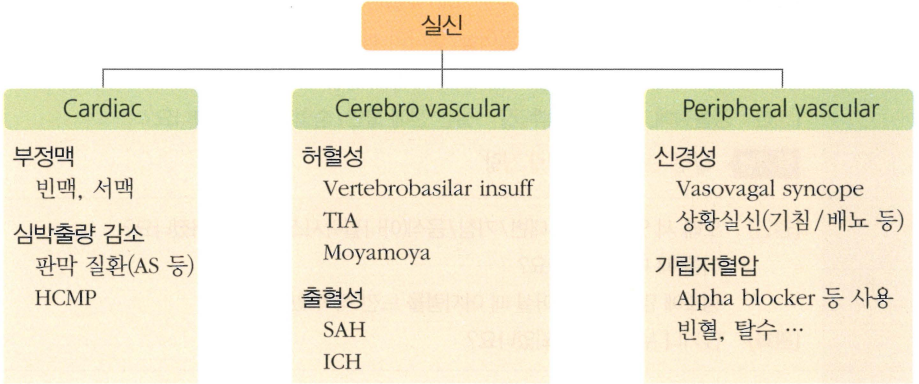
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
자율 신경 이상	혈관미주신경 실신★ (vasovagal syncope)	[병력] 오래 서 있거나, 매우 덥거나 혼잡한 환경에 오래 있거나, 음주, 피로, 통증, 공복, 심한 기침 등의 스트레스 상황에 서 전구 증상 있고 실신	[검사] 심전도, 기립경사검사(Head-up tilt test) 등으로 다른 질환 배제 [치료] 실신 상황 회피, 베타 차단제, SSRI, Midodrine, 혈관수축제
	기립 저혈압★ (orthostatic hypotension)	[병력] 눕거나 앉은 자세에서 갑자기 일어설 때 실신 (심한 탈수나 출혈 등 혈량 저하증이 동반되어 나타날 수 있음), 당뇨 합병증	[검사] 누운 상태 혈압에 비해 일어선 직후 3분 이내 측정된 혈압이 20/10 이상 감소 [치료] 움직이기 전에 다리 먼저 움직이고 천천히 일어나기, 원인 약제 조절, 충분한 수분 섭취, Midodrine

자율 신경 이상	배뇨 실신 (micturition syncope)	[병력] 배뇨 중이나 배뇨 직후 실신 (주로 한밤중 잠에서 깨서 소변 볼 때 실신)	[검사] - [치료] 일어나기 전 잠시 앉아 있기, 앉아서 소변 보기, 자기 전 소변 보기
순환기	심근경색증 (MI)	[병력] 전형적 흉통, 호흡곤란 [검진] 심잡음(S3)/경정맥 확장, 흉부 청진 상 수포음	[검사] 심전도, 심근효소검사, 관상동맥조영 [치료] 관상동맥재개통술(coronary revascularization), Nitroglycerin, 아스피린, 클로피도그렐, 베타 차단제
	비대심근병증 (hypertrophic cardiomyopathy)	[병력] 젊은 나이, 운동 시 호흡곤란, 운동하다가 실신, 가족 중 급사 병력 [검진] Valsalva 시 증가하는 수축기 심잡음	[검사] 심전도, 심초음파 [치료] 베타 차단제, non-DHP CCB, 격렬한 운동 금지, 고위험군은 ICD, 약물 치료 안 되면 수술
	부정맥 (arrhythmia)	[병력] 두근거림 후 실신(서맥 후 실신도 고려해야 함) [검진] 맥박 이상	[검사] 심전도, Holter monitoring [치료] 베타 차단제, 칼슘 통로차단제
	빈혈	[병력] 피로, 어지럼, 호흡곤란, 위절제술 병력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, Peripheral blood smear, Ferritin [치료] 원인에 따른 치료
	대동맥박리	[병력] 찢어지는 듯한 극심한 흉통, 의식 소실, 어지럼, 호흡곤란	[검사] 흉부 CT, 흉부 X-ray [치료] 응급 개흉 수술, 베타 차단제
뇌	지주막하출혈 (subarachnoid hemorrhage)	[병력] 고혈압, 극심한 두통, 구토, 의식 소실 [검진] 수막 자극 징후(+)	[검사] Brain CT, CSF tapping, 뇌혈관조영 [치료] 뇌동맥류결찰술, 산소 공급, 혈압 조절, 뇌부종 오면 VP shunt
	일과성 허혈 발작★ (TIA)	[병력] 편마비, 안면마비, 저림, 언어장애 등이 24시간 이내에 발생 후 회복	[검사] 뇌 CT/MRI, 원인 알기 위한 EKG, 심초음파 [치료] 항혈소판제, 항응고제, 목동맥내막 절제술, 원인 질환(고혈압, 고콜레스 테롤혈증, 당뇨 등) 치료, 혈전 위험 인자 교정
내분비	저혈당 쇼크 (hypoglycemic shock)	[병력] 당뇨병 병력, 인슐린 투여, 두근거림, 떨림, 식은땀 등의 증상 동반	[검사] 혈당, 전해질검사, 요중 케톤 [치료] 사탕 주스, 5% 덱스트로스 용액

정신	공황장애/ 과다환기 증후군	[병력] 실신 전에 불안하거나 숨을 헐떡임	[검사] - [치료] 인지 행동 치료, SSRI
----	-------------------	-----------------------------------	---

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제 실신하셨나요? (의식을 잃었었나요) 실신 시에 어떤 상황이었나요?/자세는 어땠나요?
L	어디에서 실신하셨나요? 쓰러지면서 다치신 곳이 있나요?
D	얼마 동안 의식을 잃으셨나요?
Co	-
Ex	이전에도 실신하신 적이 있나요?/얼마나 자주 있나요?
C	목격자가 있나요? → 실례지만 대소변을 지리진 않았나요? 어떤 모습으로 기절했나요? (경련 R/O) 실신했을 때 팔다리를 떨진 않았나요? 눈이나 고개가 한 쪽으로 돌아가지는 않았나요? 혀를 깨물었나요? 암기법 재(지)털(떨)이 옆에 돌(돌)깨

	[전조 증상] 눈앞 캄캄/메스꺼움/식은땀/어지럼이 있었나요? [실신 후] 심한 두통/피로/손발저림이 있었나요? 암기법 두피가 저리다
A	[전신] 열/체중 변화 [순환기] 어지럼/가슴 통증/두근거림/호흡곤란이 있었나요? [뇌출혈/TIA] 심한 두통/구토/말어눌/팔다리 힘이 빠졌나요? [저혈량증] 최근 심한 출혈(토혈, 혈변, 흑색변, 많은 생리)/탈수(설사, 구토)가 있었나요? [정신 : 공황장애, 과다환기증후군] 실신 전에 불안/숨쉴떡임이 있었나요? 암기법 실신 전후로 순출혈량 정량
F	[원인] 오래 서 있기/소변, 대변/기침/음식(아나필락시스) 먹고 쓰러졌나요? 더울 때 더 심해지나요? 평소에 앉았다가 일어설 때 어지럼을 느낀 적이 있나요? [완화] 앉거나 누우면 호전되었나요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	최근에 머리를 다친 적이 있나요? 수술을 받은 적이 있나요?
과	알고 계신 질환이 있나요? (고혈압/당뇨 - 인슐린 치료 여부 묻기/심질환) (의심 시) 정신건강의학과 진료를 받은 적이 있으신가요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (고혈압, 전립선약 → 실신 유발 가능) → 있다면 언제부터 약을 드시기 시작하셨나요?
사	술을 드시나요? 담배를 피시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 최근 스트레스를 많이 받으셨나요?
가	가족 중 비슷한 증상 있으신 분 있었나요? 가족 중 심혈관 질환이나 뇌졸중을 앓으신 분 있나요?
여	-

	일반적인 경우	소화기 실혈이 의심될 경우
	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기).	
P/E	[앉아서] 1. 두부외상 여부 확인 2. 눈 : 결막(빈혈) 3. 입 : 혀(탈수) 4. 목 : 경동맥 청진 5. 맥박 : 좌우 손목 맥박 측정 6. 뇌신경검사 : 동공 반사, 안구 움직임, 얼굴 감각, 얼굴 운동 + 순환기 의심 시 심음 청진 [침대에 앉아서] 7. 팔다리 : 감각/근력/DTR [누워서] 8. 수막 자극 징후 + 순환기 의심 시 경정맥 시진	[앉아서] 1. 두부외상 여부 확인 2. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 3. 입 : 혀(탈수) 4. 뇌신경검사 : 동공 반사, 안구 움직임 5. 피부 : 손등 피부 긴장도 [누워서] 6. 복부 시-청-타-촉 7. 수막 자극 징후 + 시간 여유 있으면 팔다리 감각/근력/DTR 간단하게 시행(아예 못할 수도 있을 듯)
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?	

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 쓰러지셔서 많이 걱정이 되셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 혈관미주신경 실신이 가장 의심됩니다.
기전 설명	이 질환은 자율신경 이상으로 발생하는 질환입니다.
감별 진단	하지만 그 외에 기립성 저혈압, 부정맥 등도 완전히 배제할 수 없습니다.

검사	따라서 정확한 진단을 위해 기립경사검사와 심전도검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 혈관미주신경 실신이 확진된다면 특별한 치료 없이 우선 지켜 볼 수 있습니다.
예후	[혈관미주신경 실신] 이 질환은 대부분 자연적으로 호전됩니다. 하지만 지속적으로 실신이 발생할 경우 약물 치료가 필요할 수 있습니다. [다른 질환] 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[혈관미주신경 실신] 덩거나 사람 많은 곳 피하고, 피로하거나 스트레스 받지 않도록 주의 전조 증상이 있을 때 머리를 낮추고 편안한 장소에 앉아서 휴식 취하기 [기립성 저혈압] 일어날 때는 먼저 다리를 움직이고 나서 천천히 단계적으로 일어나기 [저혈당] 당뇨약 적절하게 복용하도록 교육, 저혈당 대비하여 사탕 먹을 것 주변 사람에게 실신에 대해 알리고 조치를 알려주세요. → 기도 확보, 옷 느슨하게 하기
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 기립성 저혈압 : 자세에 따른 혈압 변화 측정
- ② 미주신경성 실신 : Head-up tilt test
- ③ 심장인성 실신 : EKG, 심초음파, 24시간 holter 검사
- ④ 저혈당 : 혈당검사, 혈중 insulin, C-peptide, 전해질검사, 소변검사
- ⑤ 뇌출혈, 뇌경색, TIA : 뇌 CT, 뇌 MRI, 뇌척수액검사

❖ 치료 계획

- ① 약물 치료 : Beta blocker, SSRI
- ② 약물 치료로 호전 없을 경우 : Pacemaker

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 실신이 일어나는 상황 피하도록 교육, 환자 질환을 주변 사람에게 설명하고 필요 시 두부 보호가 필요하다는 것 주지, 필요 시 두부 보호구 착용
- ② 탈수를 유발하는 술을 멀리하고 물을 자주 마시기

- ③ 주변 사람에게 교육 : 실신 발생 시 수평으로 눕히고 머리는 한쪽으로 돌려 흡인
막고 기도 유지, 목이나 허리를 강하게 조이는 옷/벨트 풀기, 환자의 입에 아무 것
도 넣지 말고 위약감이 사라질 때까지 눕히기
- ④ 실신 전조 증상이 느껴질 경우 안전한 장소에서 휴식 및 안정을 취하게 교육



keyword

실신 전, 중, 후의 증상이나 상황에 대한 자세한 병력 청취
의심되는 발병 부위에 따라 유연하게 신체 진찰하기
원인 감별 전까지 침상 안정 교육, 이동 시 보호자와 동반하도록 교육하기
실신 원인에 따라 유발 상황 회피 및 교육하기

자율신경	미주신경	오래 서 있음, 전구 증상
	기립성	일어날 때 실신
순환	MI	흉통, 심잡음, 경정맥 확장
	부정맥	두근거림, 맥박 이상
	HCMP	젊음, 운동 시 호흡곤란, 가족 급사
뇌	TIA	편마비, 언어장애 등이 발생 후 24hr 내 회복
내분비	저혈당	당뇨, 인슐린 투여, 두근, 식은땀
정신	공황/과다 환기	불안/숨쉴떡